阶梯式言语康复护理对帕金森病言语障碍患者的应用

吴　琪　庄红霞　荆晓雷　岳佳佳　龙玲燕　李　娟

【中图分类号】 R472　【文献标识码】 A　【文章编号】 1671-8054（2020）02-0063-03

【摘　要】 目的:探讨阶梯式言语康复护理对帕金森病患者言语功能的影响。方法:将医院收治的100例帕金森病患者,按照随机数表法分为对照组和观察组。对照组患者接受常规护理方法,观察组患者接受阶梯式言语康复护理方法。两组患者均采用嗓音障碍指数（VHI）、统一帕金森病评分量表（UPDRS-Ⅲ）运动部分的言语表达量表及言语清晰度量表评分。结果:干预8周后两组患者的VHI、UPDRS-Ⅲ运动部分的言语表达量表评分均有所下降。言语清晰度量表评分较干预前提高,且观察组患者VHI、UPDRS-Ⅲ运动部分的言语表达量表评分低于对照组,言语清晰度评分高于对照组,差异有统计学意义（$P<0.05$）。结论:阶梯式言语康复护理能有效改善帕金森病患者的言语功能和生活质量,提高康复效果。

【关键词】 言语康复　励-协夫曼言　帕金森病　生活质量

言语障碍是帕金森病患者的常见问题之一[1]。在帕金森病患者中有50%~90%的患者会发生言语障碍,其表现主要为发声不协调、发声疲劳、声音嘶哑、语言表达的清晰程度下降等[2]。杨美芳等[3]研究表明励-协夫曼言语治疗能显著提高帕金森病患者的发音音量,延长发音时间,改善音质,但由于训练强度大,机体较差的老年帕金森病患者往往不能耐受。阶梯式言语康复训练以口肌群、舌肌群、嗓音为主的基础训练,在此基础上进行以励-协夫曼言语康复为主强化训练,此方法循序渐进,形成阶梯式逐渐强化的态势,提高了患者耐受性及病情恢复的信心,在帕金森病患者言语功能及生活质量方面取得了良好的效果。现报道如下:

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取本医院神经外科自2018年11月-2019年9月收治的100例帕金森病患者作为研究对象,将其随机分为实验组和对照组,各50例。①入选标准:符合英国帕金森病协会（UKPDS）制订的PD 诊断标准;无明显认知障碍;对本研究知情同意并愿意配合。②排除标准:精神病和严重器质性疾病;声带小结、胃食管反流、喉癌等疾病的患者;参加其他语言方面康复的患者。

1.2　方法

1.2.1　对照组　患者接受常规护理方法,主要包括舌唇运动、节奏、发声等方面的训练。

1.2.2　观察组　患者接受阶梯式言语训练即首先是基础言语训练:口肌、舌肌、面肌运动,控制节律和语速等。每天3次,每次30~40 min,持续3周。在基础训练的基础上进行励-协夫曼言语强化训练,每天2次,每次30~40 min,持续5周。

1.2.2.1　组建“阶梯式言语康复”护理团队　团队成员由护士长、医生、帕金森专科护士共12人。干预前,由负责人进行为期2周的培训,以幻灯片的形式向相关人员讲解阶梯式言语康复护理的相关知识,同时要求研究组成员熟练掌握研究内容,急救知识及不良事件紧急处理措施。

1.2.2.2　训练前言语障碍量表评分　符合入选标准的患者在入院24 h内入组,由团队护士亲自发放问卷,采取面对面的形式问卷,保证资料收集的准确性和完整性。入院第2天根据患者情况制定阶梯式言语康复训练。

1.2.2.3　阶梯式言语康复之基础篇　①晨间呼吸训练:呼吸时间尽量以2:1的比例,尽最大努力完成腹部呼吸,每次呼吸运动时间相等,保证声音的强度和节奏。根据患者自身的病情逐渐增加训练强度。②早餐后训练面部肌肉和面部表情:咀嚼、吹口哨、鼓起脸颊、伸舌、吐舌头等动作,使神经和肌肉协调度、敏感度逐渐增加。③中餐后舌唇训练:进行伸舌和缩舌练习,把舌头放在嘴唇上做环形练习。伸出舌头,分别触摸两边的下巴、鼻子、嘴角,进行有力的反复交替练习。训练时间:每天练习3次,每次15~30 min。④后1周进行音量和语速练习:在训练中,发音应该在镜子前独立而有规律地进行,重点放在嘴巴上,观察嘴巴的形状和舌头的运动,听音量,调节声调。反复实践,循序渐进,效果更好。每天练习2次,每次15 min。⑤节奏和速度的控制:在说话之前,患者将句子分成几个部分,使冗长和多余的句子简洁,深呼吸后开始发音,并有意识地一个单词一个单词地发音。训练时间不受限制,患者耐受力越久越好。

1.2.2.4　阶梯式言语康复之强化篇　强化训练的前半部分为阶梯式音量和语速的强化训练,每天2次,连续2周共28次训练:①张口训练时患者的

作者单位:中国科学技术大学附属第一医院南区神经外科　安徽合肥　230036
通信作者:龙玲燕,女,主管护师
2019-12-05收稿,2020-01-13修回

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

口形尽可能长时间的发元音。②训练患者尽可能扩大声音的频率范围。③句子训练时指导患者选择日常生活中使用的10个短语或句子进行语音训练。

1.2.2.5 强化训练的后半部分为阶梯式声强训练 第1周为简单的单字及词语的训练,第2周为单句及短话的训练,第3周鼓励患者大声朗读的训练,第4周以情景模拟的形式进行日常生活交际用语的训练。每天2次,连续3周共42次训练。

1.2.2.6 总结与评价 阶梯式言语训练结束后根据量表评分对实施效果进行评价,并对干预前后数据结果进行统计分析。小组成员每月召开反馈会,讨论存在问题。

1.3 评价工具 ①嗓音障碍指数量表评分:嗓音障碍指数量表[4]总分0~120分。总分越高,发音障碍越严重。②UPDRS-Ⅲ运动部分言语表达评分:统一帕金森病评分量表包括6个部分,选用运动部分的言语表达评分项,分为5个等级,从零级到四级言语障碍程度逐渐增加。③言语清晰度评定:采用王国明言语清晰度字表法[5],该量表共200个单字,根据汉语语音学理论和临床患者较易出现的异常语音设计而成。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0统计学软件进行数据分析,计量资料用($\bar{x} \pm s$)表述,使用t检验,$P < 0.05$为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般资料 观察组50例患者,年龄40~55岁,平均年龄(48.76±7.21)岁,其中男22例,女28例,病程7~13年,平均病程(9.02±3.71)年,文盲10例、小学15例、初中16例、高中及以上9例。观察组50例患者,年龄43~63岁,平均年龄(48.76±7.21)岁,其中男20例,女30例,病程8~14年,平均病程(9.68±4.11)年,文盲10例、小学19例、初中14例、高中以上7例。两组患者在性别、年龄、病程及教育程度方面差异均无统计学意义($P > 0.05$),具有可比性。

2.2 两组嗓音障碍指数、UPDRS-Ⅲ言语表达评分、言语清晰度评分的比较 干预8周后两组患者的嗓音障碍指数(VHI)、UPDRS-Ⅲ言语表达评分均有所下降,言语清晰度评分较干预前高。且观察组VHI、UPDRS-Ⅲ言语表达评分低于对照组,言语清晰度评分高于对照组,差异有统计学意义($P < 0.05$),见表1。

表1 两组患者嗓音障碍指数、UPDRS-Ⅲ言语表达评分、言语清晰度评分的比较($\bar{x} \pm s$,分)

项目	干预前		t	P	干预后		t	P
	观察组(50例)	对照组(50例)			观察组(50例)	对照组(50例)		
嗓音障碍指数VHI	76.58±7.96	75.78±6.27	0.05	0.96	61.02±5.83	71.51±5.82	−8.52	0.00
UPDRS-Ⅲ言语表达评分	2.78±1.09	2.52±1.07	0.04	0.96	1.66±1.08	2.04±0.78	−2.01	0.04
言语清晰度	53.12±5.26	53.38±5.41	0.13	0.89	73.01±6.81	60.58±5.93	9.73	0.00

3 讨 论

传统言语康复训练仅仅在速度、韵律、声强和呼吸的控制训练,且维持时间较短,长期的效果有限。阶梯式言语康复之基础篇重点在于提高患者声音响度,增加声带内收运动,以训练呼吸肌和喉肌功能,使得发声系统更为有效,更注重长期效果的维持。强化篇重点在改善帕金森病患者的语言功能,促进其感受自身发声运动障碍的能力,并重新调整发声的感觉运动系统。此外,阶梯式言语训练能扩大其交际范围进而提高患者言语功能,增加患者自信心,改善生活质量。本研究显示,阶梯式康复护理8周后,两组患者康复训练后的言语清晰度评分较组内治疗前有明显提高($P < 0.05$),且观察组评分高于对照组($P < 0.05$),表明阶梯式言语康复护理能有效改善帕金森病患者音质、音调和清晰度,提高其言语功能。

综上所述,阶梯式言语康复护理能够使帕金森病患者说话时更加轻松、嗓音更加稳定、发音更加清晰。从生理、心理及情感上都有不同程度的改善,从而让患者更好地回归社会。由于本研究受到人力、经济等因素的影响,研究干预样本量较少,应扩大样本量对研究效果持续性进行探讨。

参考文献

[1] 吴毅.美多巴治疗帕金森言语障碍的临床观察[J].医药前沿,2016,6(15):222~223.

[2] 罗佳,庄佩耘,张天宇,等.帕金森病患者的言语障碍及励-协夫曼言语治疗的应用[J].听力学及言语疾病杂志,2007,15(6):502~505.

[3] 杨美芳,赵健,且亚玲.励-协夫曼言语治疗对帕金森病患者言语功能及生活质量的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2017,39(1):43~47.

[4] 徐芳,刘超,张帅.男声女调患者与正常男性嗓音参数的对比分析及临床意义[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2018,24(5):44~47.

[5] 陈晓春,潘晓东.神经科查体及常用量表速查手册[M].北京:化学工业出版社,2013:93~100.

(下转第67页)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

早期下床护理干预,可有效改善指脉氧饱和度,增加肺活量,促进患者肺功能康复并降低肺不张及肺部感染的发生率,在临床护理中值得进一步推广与应用。

参考文献

[1] 陈晓伟,阮新民.冠状动脉搭桥术术后肺部并发症相关风险因子分析[J].中西医结合心脑血管病杂志,2004,2(1):21~22.

[2] Toshihiro F,Minoru T,Masataka T,et al.Extensive reconstruction of the left anterior descending coronary artery with an internal thoracic artery graft[J].Ann Thorac Surg,2011,91(2):445~451.

[3] Muellera XM,Tinguelya F,Tevaearaia HT,et al.Impact of duration of cheast tube drainage on pain after cardiac surgery[J].Eur J Cardiothorac Surg, 2000, 18(5):570~574.

[4] 蔺建宇,樊华,张栋.快速康复外科理念在老年急性胆囊切除术病人护理中的应用[J]. 护理学杂志,2011,26(14):45.

[5] 常青,王亚楠.微血管减压术后病人早期下床活动的可行性研究[J].护理研究,2017,31(3):374~376.

[6] 彭娜.全髋关节置换术后髋关节脱位的护理对策及对术后早期下床活动的影响[J].当代护士(下旬刊),2018,25(2):69~71.

Effect of early out-of-bed nursing intervention on pulmonary complications after CABG with LIMA

Nanjing Hospital Affiliated to Nanjing Medical University, Nanjing 210000, Jiangsu

BO Lei

Abstract:*Objective:*To explore the effect of early out-of-bed nursing intervention on pulmonary complications after CABG with left internal mammary artery (LIMA). ***Methods:***100 patients who underwent CABG operation in hospital were selected. They were divided into control group and observation group by random number table method, 50 cases respectively. The control group received routine nursing intervention, while the observation group received early out-of-bed nursing intervention on the basis of routine nursing intervention. The incidence of finger pulse oxygen saturation, oxygenation index, vital capacity, atelectasis and pulmonary infection in the two groups were observed and compared. ***Result:*** There was no significant difference in the index of finger pulse oxygen saturation between the two groups before getting out of bed ($P > 0.05$), but the two groups after getting out of bed showed that the observation group was significantly better than the control group ($P < 0.05$); the incidence of atelectasis and pulmonary infection in the observation group was significantly lower than that in the control group ($P < 0.05$). The oxygenation index and vital capacity of the observation group were significantly better than those of the control group ($P < 0.05$). ***Conclusion:*** Early out-of-bed nursing intervention for patients undergoing CABG can effectively improve the oxygen saturation of finger pulse and reduce the incidence of atelectasis and pulmonary infection, which is worthy of further promotion and application in clinic.

Key Words: Early out-of-bed nursing; Left internal mammary artery; Coronary artery bypass surgery; Postoperative pulmonary complications　/（编审:周陶成　施仲赋）

（上接第64页）

Application effect of stepped speech rehabilitation nursing in patients with parkinson's disease

The First Affiliated Hosptital Of USTC, Hefei 230036, Anhui

WU Qi, ZHUANG Hong-xia, JING Xiao-lei, et al

Abstract:*Objective:*To explore the effect of stepped speech rehabilitation nursing on speech function of patients with Parkinson's disease (PD). ***Methods:***A total of 100 patients with Parkinson's disease admitted to the Department of Neurosurgery of the first affiliated Hospital of the University of Science and Technology were randomly divided into control group and observation group. The control group was treated with routine nursing method, and the observation group was treated with stepped speech rehabilitation nursing method. The speech expression scale and speech clarity scale of the motor part of the unified Parkinson's disease rating scale (UPDRS-Ⅲ) and the voice disorder index (VHI) were used in both groups. ***Results:***After 8 weeks of intervention, the scores of VHI and UPDRS-Ⅲ speech expression scale decreased in both groups. The score of speech clarity scale was higher than that before intervention. The scores of speech expression scale of VHI and UPDRS-Ⅲ in the observation group were lower than those in the control group, and the scores of speech clarity in the observation group were significantly higher than those in the control group ($P < 0.05$).***Conclusion:***Stepped speech rehabilitation nursing can effectively improve the speech function and quality of life of Parkinson's disease patients, and improve the rehabilitation effect.

Key Words: Speech rehabilitation; Lee Silverman; Parkinson's disease; Quality of life　/（编审:任春霞　施仲赋）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net